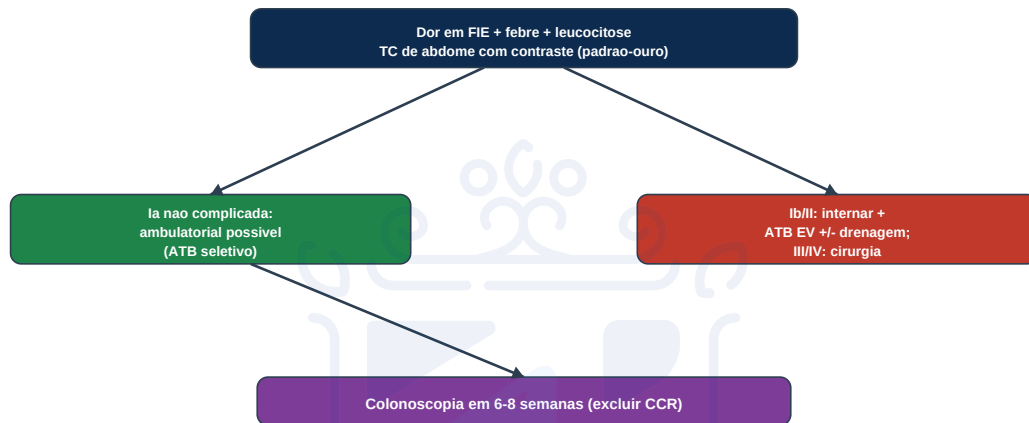


DIVERTICULITE AGUDA — HINCHEY + TC

FLUXOGRAMA — TC DEFINE HINCHEY

DIVERTICULITE — DOR EM FIE -> TC -> HINCHEY



DIAGNÓSTICO

CLÍNICA + TC

- Inflamação/infecção de divertículos colônicos (mais no SIGMOIDE), de localizada a perfuração com peritonite/sepse
- Dor CONTÍNUA em fossa ilíaca esquerda, febre, náuseas/vômitos, alteração do hábito, distensão, disúria (irritação vesical)
- Idosos e imunossuprimidos podem ter pouca dor — atenção
- Exame: dor e defesa em FIE; sinais peritoneais sugerem complicação
- Laboratório: hemograma (leucocitose), PCR/procalcitonina, função renal, lactato, urina I, beta-hCG (mulheres)

IMAGEM

TC É O PADRÃO-OURO

- TC de abdome com contraste IV: confirma o diagnóstico e define o HINCHEY
- Achados: espessamento parietal, inflamação da gordura pericólica, divertículos inflamados, abscesso, ar/líquido livre
- COLONOSCOPIA é CONTRAINDICADA na fase aguda (risco de perfuração)
- Colonoscopia eletiva em 6-8 semanas após a resolução para EXCLUIR câncer colorretal
- US/RM em situações selecionadas (gestante, dúvida)

CLASSIFICAÇÃO DE HINCHEY

Grau	Achado / conduta
Ia	Flegmão/inflamação pericólica, sem abscesso (não complicada)
Ib	Abscesso pericólico pequeno (< 4 cm) — internar + ATB EV
II	Abscesso > 4 cm (pélvico/retroperitoneal) — ATB EV + drenagem percutânea
III	Peritonite PURULENTA generalizada (perfuração contida) — cirurgia
IV	Peritonite FECAL (perfuração livre) — emergência cirúrgica

TRATAMENTO POR GRAVIDADE

Rx SUPORTE + ATB + DRENAGEM/CIRURGIA

Suporte: jejum, acesso, cristaloide (SF/Ringer 20-30 mL/kg se sepse), correção eletrolítica; analgesia (Dipirona; Morfina se intensa; EVITAR AINE em idoso/DRC/sepse)

NÃO complicada (Ia): pode ser ambulatorial se estável, sem comorbidade grave, dor controlável e aceitando VO — ATB NÃO obrigatório em jovem imunocompetente estável; usar se febre persistente/PCR alta/idoso/imunossuprimido

VO (7 dias): Amox-clavulanato 875/125 12/12h; ou Cipro 500 12/12h + Metronidazol 500 8/8h

Complicada leve (Ib): internar + EV — Ceftriaxona 1-2 g/dia + Metronidazol 500 8/8h, ou Pipe-tazo 4,5 g 6/6h (7 dias, transição VO)

Complicada (II): Pipe-tazo 4,5 g 6/6h (ou Cefepime + Metronidazol) + DRENAGEM percutânea do abscesso (7-10 dias); falha -> cirurgia

Grave (III/IV): EMERGÊNCIA cirúrgica + ATB amplo (Meropenem/Imipenem/Pipe-tazo); cirurgia de Hartmann, anastomose primária ± ileostomia, lavagem laparoscópica (III selecionados)

UTI / FALHA / ALTA

DECISÃO

- ☐ UTI: choque séptico, lactato elevado, insuficiência respiratória, IRA, peritonite difusa
- ☐ Falha do tratamento clínico: dor > 72h, febre mantida, PCR em elevação, piora na TC -> reavaliar drenagem/cirurgia
- ☐ ALTA: afebril, dor controlada VO, dieta tolerada, ATB VO (se indicado), seguimento ambulatorial
- ☐ COLONOSCOPIA obrigatória em 6-8 semanas (excluir CCR)
- ☐ Orientar sinais de retorno (dor intensa, febre, distensão, parada de eliminação)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ anos com dor em FIE + febre; sinais peritoneais ____; leucócitos/PCR ____; lactato ____.
- TC: ____ (abscesso? ar/líquido livre?); Hinchey ____.
- Condutas: jejum, hidratação, ATB ____ iniciado às ____, analgesia; drenagem percutânea ____.
- Solicito: () internação + ATB EV () drenagem (Hinchey II) () cirurgia URGENTE (III/IV) ± UTI.

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual é o exame padrão-ouro para diagnóstico e classificação (Hinchey) da diverticulite aguda?

- A) Colonoscopia na fase aguda
- B) Tomografia de abdome com contraste
- C) Enema opaco
- D) Ultrassom isolado
- E) Radiografia simples de abdome

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Diverticulite Hinchey IV (peritonite fecal). Qual a conduta?

- A) Antibiótico oral ambulatorial
- B) Emergência cirúrgica (ex.: cirurgia de Hartmann) com antibiótico de amplo espectro
- C) Apenas drenagem percutânea
- D) Colonoscopia imediata
- E) Observação clínica

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Sobre o antibiótico na diverticulite NÃO complicada (Hinchey Ia), é correto:

- A) Sempre carbapenêmico EV
- B) Não é obrigatório em jovem imunocompetente estável; indicado se febre persistente, PCR elevada, idoso ou imunossuprimido
- C) Contraindicado em todos
- D) Apenas via endovenosa por 21 dias
- E) Substituível por colonoscopia

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Diverticulite com abscesso ≥ 4 cm (Hinchey II). Qual a conduta inicial?

- A) Cirurgia de Hartmann imediata para todos
- B) Antibiótico EV + drenagem percutânea do abscesso
- C) Apenas antibiótico oral
- D) Colonoscopia de urgência
- E) Alta com analgesia

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Após resolução de um episódio de diverticulite aguda, qual exame é obrigatório em 6-8 semanas?

- A) Nova tomografia de rotina
- B) Colonoscopia, para excluir câncer colorretal
- C) Ressonância de abdome
- D) Endoscopia digestiva alta
- E) Nenhum exame adicional

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: B

A TC de abdome com contraste é o padrão-ouro: confirma o diagnóstico e define o Hinchey. A colonoscopia é contraindicada na fase aguda pelo risco de perfuração.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Hinchey IV (peritonite fecal por perfuração livre) é emergência cirúrgica (cirurgia de Hartmann é clássica), com antibiótico de amplo espectro e suporte de UTI.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na diverticulite não complicada (Ia), o ATB não é obrigatório em pacientes jovens, imunocompetentes e estáveis; reserva-se a febre persistente, PCR elevada, idosos ou imunossuprimidos.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

No Hinchey II (abscesso ≥ 4 cm), a conduta é antibiótico EV + drenagem percutânea do abscesso; a falha da drenagem indica cirurgia.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

A colonoscopia é obrigatória 6-8 semanas após a resolução, para excluir câncer colorretal subjacente.

SM24
Suporte ao Plantão Médico